



MARKETING Y VENTAS PARA CLÍNICAS DENTALES

# Las 6 fugas de una *clínica dental*.

Las seis fugas operativas que veo recurrentemente en clínicas dentales españolas, cómo medirlas y qué decisión tomar en cada una.

20 minutos de lectura · 5 días para arreglar la primera



**Jose María Moscardó**

Fundador, MosLab



## CÓMO SE LEE ESTE DOCUMENTO

20 minutos. Una hoja con seis números al final.

### INTRODUCCIÓN

## Para qué sirve *este documento*

Esto no es una guía. Es una auditoría. Cuando termines de leerlo (20 minutos) tendrás una hoja con seis números que dicen, en euros, dónde se está yendo el dinero cada mes en tu clínica dental.

**A quién va dirigido:** clínicas dentales entre 1 y 8 sillones que ya tienen pacientes, agenda viva y reputación local, pero sospechan que se les escapan tratamientos por procesos manuales, no-shows y falta de seguimiento. Aplica igual a clínica generalista, implantología, ortodoncia o estética dental. No aplica si todavía estás abriendo la primera clínica.

### QUÉ TE LLEVAS

- Un marco para distinguir las seis fugas operativas más comunes en una clínica dental española.
- Por cada fuga: cómo medirla con datos que ya tienes en tu agenda y software de gestión, en qué umbral debe preocuparte, una estimación de coste y la primera decisión que toca tomar.
- Una tabla de scoring para priorizar.
- Tres niveles de automatización (mínimo, completo, producción) con cifras reales de inversión.
- Un plan de cinco días para arreglar la peor.

Lo que no te llevas: tutoriales paso a paso, comparativas exhaustivas de software dental (Klinikare, Gesden, Odontonet, Dentaltools...), ni teoría sobre marketing sanitario.

### MARCO

## Qué es una "fuga" en una clínica dental

Una fuga es un punto del proceso donde estás perdiendo facturación por inacción, no por incompetencia. Tres rasgos:

1. **Es invisible en la cuenta de resultados.** No aparece como un coste, aparece como un tratamiento que no se cierra o un sillón que se queda parado.
2. **Es proporcional al volumen.** Cuantos más pacientes y más agenda tienes, más sangra.
3. **Tiene umbral.** Por debajo de cierto volumen no merece arreglarse; por encima, montar un sistema compensa al primer mes.

Las seis fugas que verás abajo aparecen sistemáticamente en clínicas entre 1 y 8 sillones, en generalista, implantología, ortodoncia y estética dental. No están en orden de gravedad: están en orden cronológico dentro del recorrido del paciente.

Un dato para encuadrar la escala. El **90% de los pacientes inicia su búsqueda online** (Doctoralia, Google, redes). Un ticket medio mezclado ronda los **300-450 €**, pero los tratamientos de mayor margen mueven la facturación: un implante completo en España cuesta entre **1.000 y 1.800 €** (media ~1.550 €), una arcada completa sobre 4 implantes **5.000-14.000 €** (media ~9.500 €), y una ortodoncia entre **2.500 y 6.000 €**. Una sola conversión adicional al mes paga el sistema entero. Tres al mes lo amortizan veinte veces.

## RECORRIDO DEL PACIENTE · 5 FUGAS DEL CICLO COMERCIAL



## CICLO LARGO · FUGA 5 · LA BASE QUE NO VUELVE

5

paciente sin reactivar → ingreso recurrente perdido

Las 4 fugas del recorrido del paciente + 1 propia de la base inactiva. La fuga 6 (contenido sin reutilizar) es transversal a todas.

## CASO TRABAJADO

### Clínica Dental SL

Antes de entrar a las seis fugas, un ejemplo concreto. Clínica dental generalista en Sevilla, 4 sillones, 12 personas (3 dentistas + 2 higienistas + 4 auxiliares + 2 recepción + 1 gerente), base de 1.800 pacientes históricos, **90 leads/mes** entre web propia, Doctoralia y recomendación. Ticket medio mezclado 380 €. Tasa de no-show actual: **12%**. Tasa de aceptación de presupuestos altos (>1.500 €): 38%. Pacientes sin venir hace más de 18 meses: 720.

Auditoría rápida, hecha en una mañana mirando el software de gestión, la agenda y la hoja de presupuestos:



## Total estimado

**27.200 € / mes**

Las fugas 3, 4 y 5 concentran el 75% del coste mensual: ahí está el Pareto. Anual: ~326.000 €.

Dos cosas que importan. Primero: el gerente llevaba 18 meses sin tocar nada y estimaba "que se perdía algún paciente". Veintisiete mil al mes son **326.000 € al año** — equivalen a un dentista a jornada completa más un higienista. Segundo: tres fugas concentran tres cuartas partes del coste. Esa es la cola de Pareto que el resto del documento sirve para identificar en tu caso. (Ojo: las fugas pueden solaparse, así que el total es una estimación de techo, no una suma contable exacta.)

## FUGA 1 · CITA SIN CONTESTAR

*El 90% de los pacientes empieza su búsqueda online. Y consulta a 2-3 clínicas en paralelo.*

# Cita *sin contestar*

## SÍNTOMA

Entra una solicitud por Doctoralia, formulario web, WhatsApp al número de la clínica o llamada perdida, y la primera respuesta tarda horas, días, o no llega. Versión peligrosa: respondéis rápido cuando la recepcionista no está en boxes, pero nada por la tarde, fines de semana o festivos.

## CÓMO MEDIRLA CON DATOS QUE YA TIENES

- Coge los últimos 30 leads recibidos por cualquier canal. Para cada uno, calcula el tiempo entre la entrada y el primer mensaje útil enviado por un humano (no autorespuesta del portal).
- Calcula la **mediana**, no la media. Una respuesta inmediata seguida de tres a los tres días distorsiona la media.
- Si tu software de gestión no lo registra, exporta los avisos de Doctoralia y el correo de recepción y crúzalos. Una hora de trabajo.

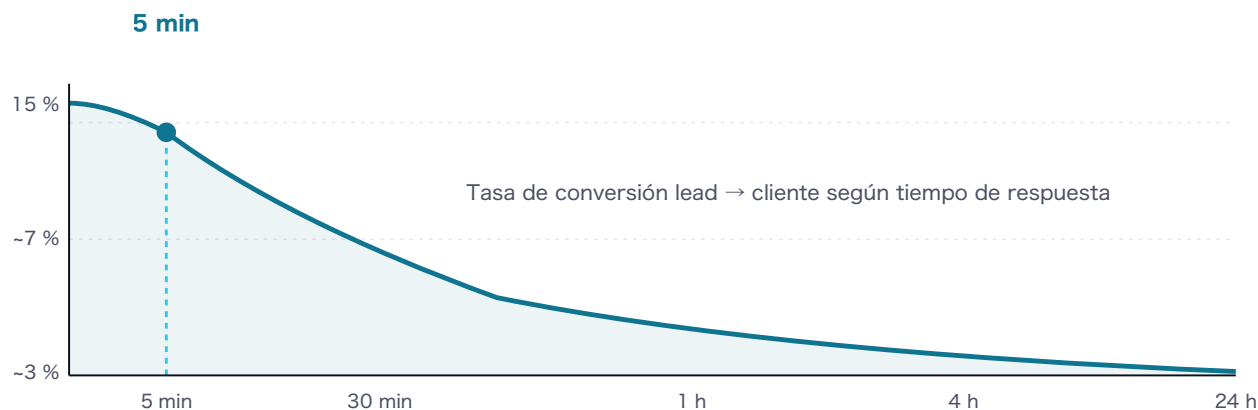
## UMBRAL

Si la mediana es mayor a **30 minutos en horario laboral**, o si más del 15% de leads tarda más de 4 horas en recibir respuesta, tienes fuga. Si las consultas de viernes por la tarde y sábado esperan al lunes, fuga grave: una parte importante del lead dental llega fuera de horario.

## CUÁNTO TE CUESTA

Los datos son contundentes desde hace casi 20 años. El estudio del MIT Lead Response Management (replicado por Harvard Business Review) muestra que un lead contactado en los primeros 5 minutos tiene **21 veces más probabilidades de ser cualificado** que uno contactado a los 30 minutos. La probabilidad de contactar es **100 veces mayor** en esa misma ventana.

Aplicado a dental: el **90% de los pacientes** empieza la búsqueda online y suele consultar a 2-3 clínicas en paralelo. Los datos de Doctoralia muestran que las clínicas con agenda online y respuesta rápida elevan su tasa de conversión hasta un **71% más** que las que dependen solo de llamada de recepción.



Dental. Después del minuto 5, cada hora que pasa cuesta pacientes. La curva no es lineal: es exponencial. Fuente: MIT Lead Response Management Study + Doctoralia 2025.

Cálculo de servilleta: si recibes 100 leads/mes, tu tasa de conversión actual es 18% y el valor medio de primer tratamiento es 250 €, pasar de respuesta de horas a menos de 1 minuto puede mover la tasa al 30%. Son 12 pacientes nuevos/mes adicionales = **3.000 €/mes adicionales**. Y cada uno de esos pacientes, en LTV dental, vale entre **1.500 y 4.000 €** a lo largo de los próximos 3-5 años.

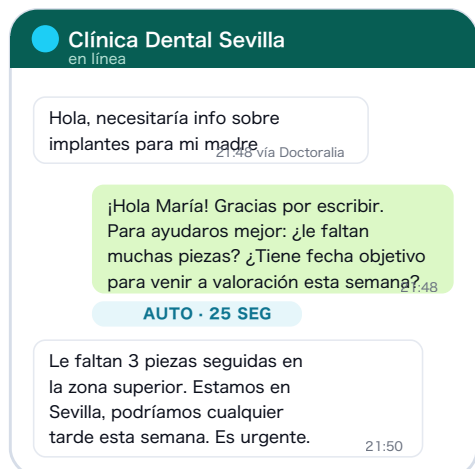
## DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Cualifico antes de pasar a recepción? Para clínicas con volumen, casi siempre sí.
- ¿WhatsApp como primera respuesta o solo email/llamada? WhatsApp gana fácil: **98% de tasa de apertura** y lectura en menos de 4 minutos.
- ¿Qué hago fuera de horario? Acuse + cualificación automática + agenda en huecos reales + handoff matinal a recepción con todo el contexto.

## LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Auto-acuse por WhatsApp en menos de 60 segundos en el canal donde entró el lead.

- Cualificación básica conversacional (tipo de tratamiento, urgencia, primera vez o paciente histórico, seguro o privado) por bot con IA antes de tocar a recepción.
- Asignación al área correcta (urgencia → dentista de guardia, estética → especialista, ortodoncia → ortodoncista) con todo el contexto.
- Reintento automático en T+15min, T+1h, T+24h si el lead no responde.



#### EL SISTEMA QUE SOSTIENE ESE MENSAJE

#### 3 piezas + 1 IA: detectar, cualificar, enrutar.

1. Webhook recibe el lead de Doctoralia, web o Google.
2. WhatsApp Business API envía mensaje conversacional.
3. IA lee la respuesta libre y la cualifica (urgencia/tipo/financiación).
4. Asignación al especialista: implantólogo, ortodoncista, generalista.

Antes

**5 h**

mediana laborable  
sin respuesta fines

Después

**<1 min**

automático 24/7  
fines incluidos

Impacto

**+71%**

conversión cita  
vs sin agenda online

Lo que ve la paciente en WhatsApp tras consultar en Doctoralia a las 21:48, y el sistema que lo sostiene. Sin tocar a recepción hasta que el lead está cualificado.

#### CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

**Generalista:** consultas de empaste o revisión que llegan a Doctoralia el viernes por la tarde y se contestan el lunes — el paciente ya tiene cita en la clínica de al lado. **Implantología:** consultas de presupuesto por web que nadie cualifica hasta que la persona ya ha visitado a otro implantólogo.

**Ortodoncia:** padres pidiendo info para sus hijos que se quedan sin respuesta y se van a Invisalign Smile Direct. **Estética dental:** consultas urgentes (boda en 2 meses, evento) que se enfrían en 30 minutos. En todos los casos: los pacientes consultan **2-3 clínicas en paralelo**. La primera que responde bien gana.

#### FUGA 2

## Paciente *sin cualificar*

#### SÍNTOMA

La recepción dedica tiempo a citas y llamadas con personas que no acaban en tratamiento: "vengo a que me digáis cuánto cuesta un implante" sin intención real de tratarse ahí, padres que piden info pero el hijo está en otra ciudad, curiosos comparando precios. La agenda médica se ocupa con primeras visitas "informativas" que no convierten.

#### CÓMO MEDIRLA

- Saca las últimas 50 primeras visitas realizadas: ¿cuántas se habrían evitado con tres preguntas previas (tipo de tratamiento, fecha objetivo, disponibilidad real de presupuesto)?
- Si tu software separa fases lead → primera visita → presupuesto → tratamiento, mira la conversión **primera visita** → **presupuesto aceptado**. Por debajo del 30% es sospechoso.

#### UMBRAL

Si más del **30% de las primeras visitas** no acaba en presupuesto presentado ni en descarte limpio, tienes problema de cualificación, no de producto.

#### CUÁNTO TE CUESTA

Una primera visita ocupa 30-45 min de un dentista (75-90 € de coste cargado) más 15 min de recepción y auxiliar. 15 primeras visitas malas al mes son **1.500 € directos**, sin contar el coste de oportunidad de no haber visto en ese hueco a un paciente listo para tratarse.

#### DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Quién cualifica? Para clínicas con volumen, lo eficiente es bot IA conversacional + confirmación humana.

- ¿Qué 4-5 preguntas son no negociables antes de agendar primera visita? Tipo de tratamiento, urgencia, fecha objetivo, financiación esperada (seguro / contado / financiación) y primera vez o paciente histórico.
- ¿Qué hago con el lead que no cualifica? **No lo tires**: entra en cola de nurturing con contenido educativo sobre su tratamiento de interés.

### LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Cuestionario conversacional de 4-5 preguntas en WhatsApp o formulario web — lenguaje natural, no formulario corporativo.
- Lógica de scoring que separe **paciente caliente** (urgencia + presupuesto + fecha → primera visita inmediata), **tibio** (nurturing semanal con casos y testimonios) y **frío** (newsletter mensual).
- Track separado para **pacientes con seguro privado** (Sanitas, Adeslas, DKV) y para **pago contado / financiación**: las dinámicas de presupuesto y aceptación son completamente distintas.

#### Scoring conversacional · 4 preguntas → 3 vías



#### CALIENTE

##### TRATAMIENTO

Urgencia / dolor / estética cierta

##### FINANCIACIÓN

Seguro privado o contado

##### TIMING

Esta semana o el mes

##### DECISOR

Habla el propio paciente

→ Primera visita YA + alerta especialista



#### TIBIO

##### TRATAMIENTO

Estética / ortodoncia planificada

##### FINANCIACIÓN

Estudia opciones / financiación

##### TIMING

Próximos 2-3 meses

##### DECISOR

Necesita validar con pareja

→ Nurturing con casos clínicos



#### FRÍO

##### TRATAMIENTO

"Comparo presupuestos"

##### FINANCIACIÓN

No definida

##### TIMING

"Más adelante" / sin fecha

##### DECISOR

Pregunta para un tercero

→ Newsletter educativa mensual

Tres vías automáticas según la cualificación. Recepción solo recibe los calientes; los demás se nutren solos sin gastar primeras visitas con dentista.

### CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

**Generalista**: primeras visitas con personas que comparan precios entre clínicas y nunca cierran.

**Implantología**: "consulta de presupuesto" sin intención real ni capacidad de pago — el implantólogo pierde 45 min de agenda. **Ortodoncia**: familiares que piden info para terceros sin presencia del decisor.

**Estética dental**: consultas de carillas con expectativas irreales sobre el resultado o el coste.

### FUGA 3

## Cita *sin confirmar* (no-show)

### SÍNTOMA

El paciente reserva cita y no aparece. El sillón queda vacío 30-60 minutos. El dentista mira el techo. La agenda del día se descompensa. En clínicas medias, esto pasa **entre el 8% y el 22% del calendario** — depende de cómo lo midas.

### CÓMO MEDIRLA

- En tu software, saca el ratio de citas marcadas como "no show" o "no acudió" frente al total de citas programadas en los últimos 3 meses. **Es el dato más fácil de sacar y el más doloroso de mirar.**
- Mira específicamente los lunes por la mañana, viernes por la tarde y el día después de un puente: ahí el no-show suele dispararse al 25-30%.

### UMBRAL

Si tu tasa de no-show supera el **8%**, fuga clara. Por encima del **15%** estás regalando un dentista a jornada parcial. Las clínicas españolas que automatizan recordatorios con confirmación activa bajan a **5-6%** en los primeros meses.

### CUÁNTO TE CUESTA

Esta es la fuga más sangrante del sector dental y la más fácil de cuantificar. Coge tu agenda media: si tienes 4 sillones × 8 horas/día × 22 días/mes = ~700 huecos/mes. Un no-show del 12% son **84 huecos perdidos/mes**.

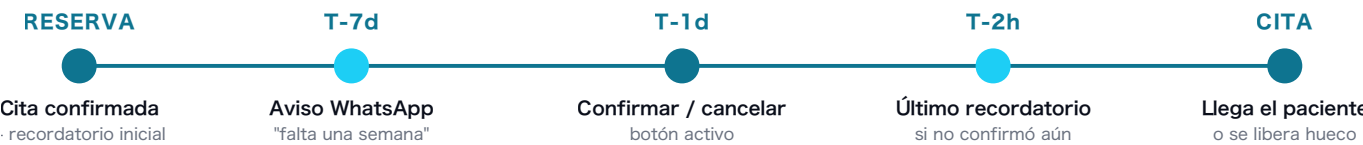


Si el valor medio de un hueco es 95 €, son **7.980 €/mes en sillón parado**. Hasta **78.000 €/año** en clínicas medias que no automatizan recordatorios.

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Recordatorio simple o con confirmación activa? La diferencia es enorme: simple reduce no-show un 20%; con confirmación activa, hasta 50%.
- ¿Qué canal? SMS y WhatsApp tienen ~98% de open rate; email mucho menos. Para dental, **WhatsApp gana**.
- ¿Cuándo recordar? T-7 días, T-1 día, T-2h funciona bien. T-1 día con confirmación activa es el mínimo viable.

CADENCIA DE RECORDATORIOS CON CONFIRMACIÓN ACTIVA



| MOMENTO  | CANAL                | MENSAJE                                                                                                                |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reserva  | WhatsApp (auto)      | Confirmación de cita + datos (fecha, hora, sillón, profesional) + dirección + cómo llegar.                             |
| T-7 días | WhatsApp             | "Hola [nombre], te recordamos que tienes cita el [día] a las [hora]. Si necesitas cambiarla, contesta a este mensaje." |
| T-1 día  | WhatsApp con botones | "Mañana a las [hora]. ¿Confirmas asistencia?" — botones: ✓ CONFIRMO · CANCELAR · REAGENDAR.                            |
| T-2h     | WhatsApp / SMS       | Solo si no ha confirmado. "Tu cita es hoy en 2 horas. ¿Vienes?". Si cancela, el hueco se libera automáticamente.       |
| Cita     | Software             | Si confirmó, llega. Si canceló, el sistema avisa al siguiente paciente de lista de espera para llenar el hueco.        |

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Recordatorio automático por WhatsApp 24h antes con **botón de confirmar/cancelar/reagendar** (no solo aviso pasivo).
- Si el paciente no confirma, segundo recordatorio T-2h con confirmación activa.
- Si cancela o reagenda, el hueco se libera automáticamente y entra en **lista de espera** — el sistema avisa al siguiente paciente que pedía esa franja.
- Para tratamientos largos (implante, ortodoncia), recordatorio adicional con instrucciones específicas (ayuno, medicación previa, etc.).

CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

**Generalista:** primera visita reservada hace 3 semanas que el paciente "ya no se acuerda". **Implantología:** revisión post-cirugía sin recordatorio adecuado — el paciente se olvida y vuelve cuando tiene un problema.

**Ortodoncia:** revisiones mensuales largas (18-24 meses) donde el adolescente pasa de ir y el padre no se entera. **Estética dental:** sesiones de blanqueamiento o limpiezas profesionales que se cancelan en el último momento sin avisar.



## FUGA 4 · PRESUPUESTO SIN CERRAR

*La tasa de aceptación objetivo en dental es del 60%. Muchas clínicas no llegan al 40%.*

### FUGA 4

## Presupuesto *sin cerrar*

### SÍNTOMA

El dentista presenta un presupuesto de implantes, ortodoncia o estética dental. El paciente dice "me lo voy a pensar". Nadie llama. El paciente compara con otra clínica, encuentra financiación más cómoda, o simplemente lo olvida. En el software, el presupuesto queda en "pendiente" durante meses.

### CÓMO MEDIRLA

- De los últimos 30 presupuestos altos (>1.500 €) presentados hace más de 21 días, ¿cuántos están en estado "pendiente" o "no aceptado" sin acción posterior?
- Calcula tu **tasa de aceptación de presupuestos altos**. Si está por debajo del 50%, fuga importante. Por debajo del 35%, fuga grave.

### UMBRAL

Cualquier presupuesto >1.500 € sin un punto de contacto programado en los **7 días posteriores** está perdiendo dinero. La consultoría dental española marca el **60% como tasa de aceptación objetivo** para presupuestos bien presentados con seguimiento estructurado.

### CUÁNTO TE CUESTA

Si tu clínica presenta 20 presupuestos altos/mes con ticket medio 2.500 € (mezcla implantes + ortodoncia + estética), pasar de un 38% a un 55% de aceptación son **4 tratamientos extra/mes = 10.000 €/mes adicionales = 120.000 €/año** por arreglar una sola fuga. Casi tan importante como el no-show.

### DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Manda el seguimiento un humano o lo automatizo? Para presupuestos >5.000 € (implantología compleja, ortodoncia), mezcla: emails automáticos + 1-2 toques humanos del propio dentista.
- ¿Qué cadencia? Cadencia de 21 días con caso clínico similar al suyo y llamada del dentista al día 9.
- ¿Qué financiación ofrezco? El **60-70%** de pacientes que aceptan presupuestos altos lo hacen con financiación (Aplazame, Pepper, financiación propia). Si no la ofreces proactivamente, pierdes pacientes.

### LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Cuando se presenta un presupuesto >1.500 €, disparar automáticamente el envío en PDF por WhatsApp + email con opciones de financiación pre-calculadas para SU presupuesto.
- Aviso al agente cuando el propietario abre el email para llamarle si toca (timing perfecto).
- Alerta automática si en 21 días no ha habido ni una visita: agente proactivo con sugerencia de bajada de precio o nueva sesión de fotos.



## Presupuesto · M. Ruiz · Implantología

TRATAMIENTO: 3 IMPLANTES + CORONAS · PRESENTADO HACE 9 DÍAS · SEGUIMIENTO AUTOMATIZADO

Importe total

**4.800 €**

3 implantes + coronas

Financiación 24m

**219 €/m**

Aplazame · 0% TAE

PDF abierto

**3 veces**

↑ buena señal

Probabilidad cierre

**68 %**

basada en patrón histórico

Cadencia automatizada · 21 días post-presupuesto

próximo: día +12 (WhatsApp recordatorio)

Día 0 - 2 - 5 - 9 (llamada Dr.) · completados

### Recomendación automatizada

Paciente abrió el PDF 3 veces y dijo "lo tengo que hablar con mi marido". Probabilidad alta de cierre con financiación. Recordatorio al dentista para llamada de cortesía esta semana.

Lo que ve el dentista en su panel: estado del presupuesto + señales de intención + próximo toque programado. Sin que pierda mentalmente el hilo de 20 presupuestos abiertos.

## CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

**Generalista:** presupuesto de varios empastes y limpiezas que el paciente "ya hará en septiembre" y nunca vuelve. **Implantología:** presupuesto de 5.000-10.000 € que el paciente compara con tres clínicas más, se va a la que le hace mejor financiación. **Ortodoncia:** familia que pide tres presupuestos para los hijos y se va al más barato sin que tú hayas explicado el plan. **Estética dental:** carillas o blanqueamientos sin urgencia que el paciente pospone indefinidamente.

## FUGA 5

# Paciente *sin reactivar*

## SÍNTOMA

Tienes una base de pacientes históricos que vinieron una vez, se trataron bien, pagaron, y nunca más se supo. La revisión anual no se convoca. El mantenimiento de implantes (recomendado cada 6 meses) no se programa. Los pacientes con ortodoncia terminada no vuelven a higiene profesional. **El 40-60% de tu base de pacientes pasiva representa entre 200 y 800 personas recuperables.**

## CÓMO MEDIRLA

- Ratio "ingreso de pacientes recurrentes / ingreso total". En clínicas saludables ronda 60-70%; si en la tuya es menor del 50%, dependes demasiado de captación nueva.
- Cuenta pacientes que pasaron por consulta hace más de 12-18 meses y no han vuelto. ¿Qué porcentaje son?

## UMBRAL

Si más del **40% de tus pacientes** no ha vuelto en 18 meses, no tienes problema de captación: tienes problema de **fidelización post-tratamiento**. Y en dental, fidelizar es 5 veces más barato que captar.

## CUÁNTO TE CUESTA

Un paciente recuperado cuesta entre **3 y 7 veces menos** que uno nuevo. Si tu coste de adquisición ronda los 60-120 €, recuperar 10 pacientes inactivos al mes te ahorra unos **1.000 €/mes en CAC**. Y si de esos 10, **3 acaban en tratamiento mayor** (implante de mantenimiento, ortodoncia para hijos, blanqueamiento estacional), el ingreso adicional supera fácil los **4.000 €/mes**.

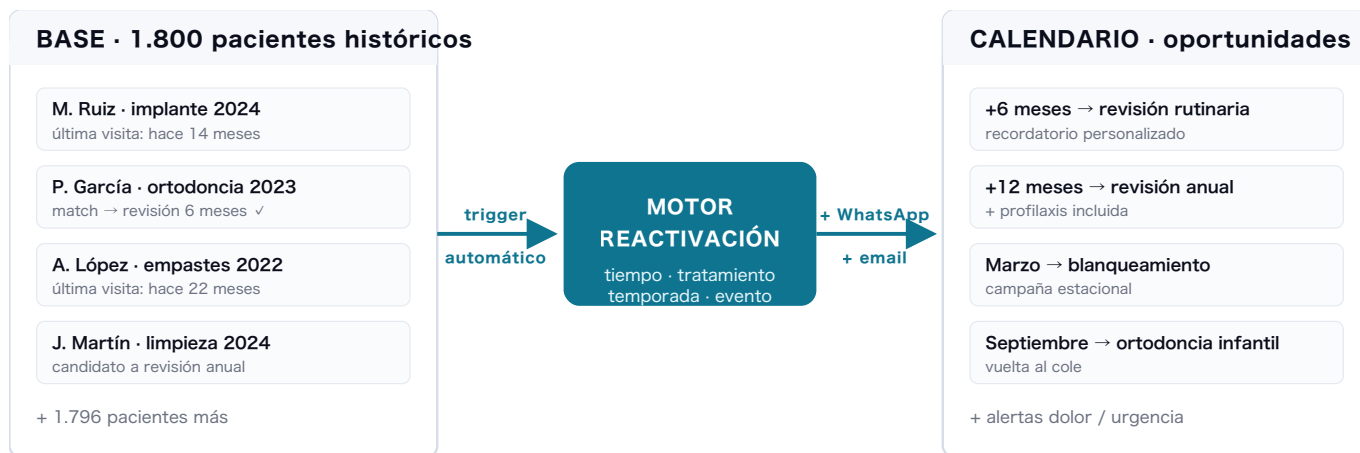
## DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Quién dispara la reactivación? Calendario fijo de recepción vs. trigger automático según ciclo dental.
- ¿Qué excusa tienes para volver a contactar sin ser pesado? La revisión anual, mantenimiento de implantes, una campaña estacional (blanqueamiento en primavera, ortodoncia infantil en septiembre), una novedad técnica relevante.
- ¿Reactivas con WhatsApp, email, llamada o mix?

## LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Recordatorio automático **a los 6 meses** post-última visita: "Hola [nombre], toca revisión para asegurar que todo sigue bien." Con link a reservar en agenda online.

- Campaña automatizada estacional (3 veces al año) a pacientes inactivos: blanqueamiento en marzo, salud dental infantil en septiembre, "regalo de Navidad" con tratamiento estético en noviembre.
- Para pacientes con implantes: recordatorio cada 6 meses obligatorio (el mantenimiento es clínicamente necesario y económicamente recurrente).
- Encuesta de satisfacción a los 3 meses post-tratamiento con opción de dejar reseña en Google si la experiencia fue buena.



Motor de reactivación: cada paciente histórico se cruza con el calendario de oportunidades (clínicas, estacionales, personales). Sin spam, máximo 4 contactos al año por paciente.

### CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

**Generalista:** paciente que se hizo dos empastes hace 3 años y nunca volvió a revisión — recuperable con un toque correcto. **Implantología:** portadores de implantes que no cumplen el protocolo de mantenimiento semestral — perdéis ingreso recurrente y aumentáis riesgo de fracaso clínico.

**Ortodoncia:** ex pacientes con tratamiento terminado hace 2-3 años que ahora necesitan retenedor o tienen recidiva. **Estética dental:** pacientes que se hicieron carillas o blanqueamiento y son perfect candidates para refrescar el resultado.

### FUGA 6

## Contenido *sin reutilizar*

### SÍNTOMA

Cada pieza educativa (vídeo del antes/después de un tratamiento, post sobre cómo funciona un implante, testimonio en consulta) requiere producirse manualmente: foto/vídeo, edición, copy distinto para cada red, story aparte, post de blog si lo hay. Una persona dedica 1-2 horas a producir cada pieza, vive en un único canal (normalmente Instagram), y se desperdicia el alcance que podría tener en blog, email a base de pacientes y newsletter.

### CÓMO MEDIRLA

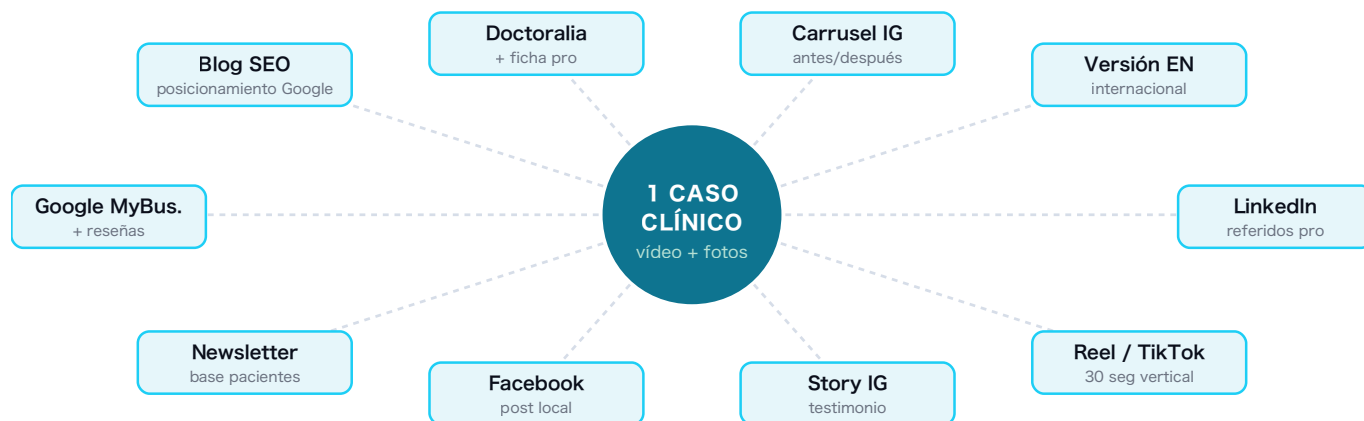
- Coge tus últimas 10 piezas de contenido (posts, vídeos, antes/después). ¿Cuántas viven en más de un canal? ¿Cuántas se enviaron por email a tu base de pacientes?
- Estima el coste-hora de producción por pieza (interno o agencia).

### UMBRAL

Si menos del **30% de tu contenido** se reutiliza en al menos otro canal, estás duplicando coste de producción para multiplicar por uno el alcance.

### CUÁNTO TE CUESTA

Una pieza pilar dental bien producida (vídeo de tratamiento, caso clínico explicado) cuesta 100-200 € entre tiempo del dentista, edición y diseño. De ahí pueden salir, sin esfuerzo extra, un email a la base de pacientes, 2-3 carruseles, 4 posts cortos, 1 reel y un par de fragmentos para Doctoralia. Si haces 4 piezas pilar al mes y reutilizas, **multiplicas por 8 tu output sin tocar el coste de producción**. 1.200 €/mes en valor equivalente.



1 → 10. Sistema 1 caso clínico alimenta 10 canales en 5 minutos de revisión humana. Multilingüe ES/EN para clínicas en zonas con paciente internacional.

## LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Subes el vídeo o las fotos del caso. La IA genera blog SEO, carrusel IG, post FB, story, reel, newsletter, ficha Doctoralia, alt-text SEO, versión inglés.
- Calendario único de publicaciones, no uno por canal.
- Revisión humana antes de publicar (10 minutos por pieza en lugar de 90).

## CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

**Generalista:** vídeo de tratamiento de caries que se queda en stories y nunca llega al blog ni a Google.

**Implantología:** caso clínico de rehabilitación completa que vive solo en Instagram, perdiendo el SEO que podría capturar búsquedas tipo "implantes en Sevilla". **Ortodoncia:** evolución de 18 meses de un caso adolescente que es oro puro para newsletter y blog y se queda en stories destacadas. **Estética dental:** antes/después de carillas que no se traduce al inglés perdiendo al paciente internacional.

# Tabla de *scoring*

Dos pasos. Primero, marca tu situación de 0 a 3 en cada fuga:

- **0:** la fuga no aplica a mi negocio.
- **1:** ya está resuelta (sistema en marcha y monitorizado).
- **2:** la sospecho pero no la he medido.
- **3:** la tengo, la veo, no he hecho nada.

Segundo, calcula el coste estimado con la fórmula correspondiente. **No estimes al ojo:** pon números reales (los tuyos, sacados del software de gestión y de la agenda).

## FÓRMULAS DE COSTE MENSUAL

| FUGA                         | FÓRMULA                                                                           | EJEMPLO                                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Cita sin contestar       | $\text{leads/mes} \times \text{valor 1ª visita} \times \Delta \text{ conversión}$ | $100 \times 250 \text{ €} \times 12\% = \mathbf{3.000 \text{ €/mes}} + \text{LTV}$       |
| 2 · Paciente sin cualificar  | $1ª \text{ visitas malas/mes} \times 95 \text{ € coste}$                          | $15 \times 95 \text{ €} = \mathbf{1.425 \text{ €/mes}}$                                  |
| 3 · No-show                  | $\% \text{ no-show} \times \text{citas/mes} \times \text{valor hueco}$            | $12\% \times 700 \times 95 \text{ €} = \mathbf{7.980 \text{ €/mes}}$                     |
| 4 · Presupuesto sin cerrar   | $\text{presup/mes} \times \text{ticket} \times \Delta \text{ aceptación}$         | $20 \times 2.500 \text{ €} \times 17\% = \mathbf{8.500 \text{ €/mes}}$                   |
| 5 · Paciente sin reactivar   | $\text{pacientes recup} \times \text{tasa} \times \text{ticket medio}$            | $50 \times 6\% \times 400 \text{ €} = \mathbf{1.200 \text{ €/mes}} + \text{recurrencia}$ |
| 6 · Contenido sin reutilizar | $\text{piezas} \times \text{coste prod} \times (\text{canales} - 1)$              | $4 \times 150 \text{ €} \times 4 = \mathbf{2.400 \text{ €/mes}}$ en valor equivalente    |

**Notas.**  $\Delta$  conversión en fuga 1 es lo que estimas que mejorará la tasa de paciente nuevo arreglando respuesta (8-15 puntos porcentuales es realista pasando de horas a segundos). En fuga 4,  $\Delta$  aceptación es lo que esperas mejorar arreglando seguimiento (15-20 puntos es realista pasando de 38% a 55%). Para fuga 3, multiplica por el valor medio de hueco real (mezcla de revisiones, empastes y tratamientos), no solo por el ticket de implante. 95 €/h es el coste cargado aproximado de un dentista español a 50-60 K€/año; ajústalo a tu realidad.

## TU TABLA

| FUGA                             | MI PUNTUACIÓN (0-3) | COSTE ESTIMADO / MES |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 · Cita sin contestar           | —                   | — €                  |
| 2 · Paciente sin cualificar      | —                   | — €                  |
| 3 · Cita sin confirmar (no-show) | —                   | — €                  |
| 4 · Presupuesto sin cerrar       | —                   | — €                  |
| 5 · Paciente sin reactivar       | —                   | — €                  |

| FUGA                         | MI PUNTUACIÓN<br>(0-3) | COSTE ESTIMADO /<br>MES |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6 · Contenido sin reutilizar | —                      | — €                     |
| <b>Total estimado</b>        |                        | <b>— € / mes</b>        |

**Regla práctica:** prioriza arreglar la fuga con mayor coste estimado/mes que esté en puntuación 2 o 3. No la más fácil. La más cara. En dental, casi siempre es la fuga 3 (no-show) o la fuga 4 (presupuestos).



## SOLUCIÓN

# 3 niveles de *automatización*

Una vez tienes el diagnóstico, viene la pregunta: ¿cuánto cuesta arreglar esto? Hay tres niveles según ambición, presupuesto y volumen. No son alternativos: el nivel 2 contiene al 1, el 3 es un add-on opcional sobre cualquiera de los dos.

**Nivel 1**

**Quick Win**

**Respuesta + recordatorios  
+ confirmación activa**

Arregla las dos fugas más sangrantes del sector:

**FUGA 1** **FUGA 3**

---

**Plazo:** 2-3 semanas

**Setup:** 1.200 – 2.500 €

**Operativo:** 60-90 €/mes

(WhatsApp API + IA, factura directa)

**Nivel 2 · recomendado**

**Sistema Completo**

**Captación + presupuestos  
+ reactivación pacientes**

Quick Win + 3 capas:

- Cualificación segmentada
- Seguimiento presupuestos altos
- Reactivación de inactivos
- Encuestas + reseñas

**F1** **F2** **F3** **F4** **F5**

---

**Plazo:** 6-10 semanas (por fases)

**Setup:** 5.000 – 8.000 €

**Operativo:** 150-250 €/mes

**Nivel 3 · Add-on**

**Producción IA**

**Contenido + casos clínicos  
multilingüe ES/EN**

Sube vídeo o fotos del caso:  
la IA genera blog SEO,  
IG, FB, story, reel, newsletter,  
ficha Doctoralia, alt-text SEO.

**FUGA 6**

---

**Plazo:** 1-2 semanas

**Setup:** 1.500 – 3.000 €

**Operativo:** 80-150 €/mes

El Nivel 2 contiene al Nivel 1 y resuelve 5 de las 6 fugas. El Nivel 3 es opcional y se monta encima de cualquiera de los dos.

**Cuándo tiene sentido cada uno.** Quick Win: desde 1 sillón con 60+ citas/mes. Sistema Completo: desde 2 sillones con 200+ citas/mes y cartera de 800+ pacientes; prácticamente obligatorio en clínicas >3 sillones. Add-on producción: desde 4 piezas de contenido/mes y especial interés en SEO o redes para captación.

Las cifras de "Operativo" son coste de herramientas de terceros (WhatsApp Business API —con coste variable por conversación—, IA y email); los honorarios de implantación y mantenimiento de MosLab se presupuestan aparte. Setup orientativo "desde", según volumen y número de sedes. La integración con software de gestión propietario o legacy puede requerir un módulo de integración adicional.

## Una nota sobre el software de gestión dental

La pregunta más común: "¿me sirve mi software actual o tengo que cambiarlo?". Respuesta corta: **casi nunca hay que cambiarlo**. La automatización vive encima del software conectándose a su API o vía sincronización. Funciona con los principales del sector — **Klinikare**, **Gesden**, **Dentaltools**, **Odontonet**, **Sanidoc** — y con los más modernos tipo Dentript o Curve Hero. Lo único necesario es que el plan tenga acceso a la API o a integraciones tipo Zapier.

Si necesitas software nuevo: **clínica de 1-2 sillones** → Klinikare o Dentaltools (40-80 €/mes, españoles, soporte en castellano). **Clínica de 3+ sillones** → Gesden o Klinikare Pro (80-150 €/mes, con módulo de marketing y agenda online integrada).

## ANTI-PATRONES

# Qué *no* automatizar

Esto es tan importante como las seis fugas. Automatizar el sitio equivocado convierte un proceso lento en un proceso roto y rápido.

### ✗ El diagnóstico clínico

Cualquier cosa que implique decisión clínica (plan de tratamiento, ajuste de presupuesto por hallazgo radiográfico, comunicación de mala noticia) la hace el dentista cara a cara. La automatización avisa, prepara, programa. Diagnostica el profesional.

---

### ✗ La presentación del primer presupuesto alto

Implante, ortodoncia, rehabilitación completa: la primera presentación es una conversación entre dentista y paciente en consulta. El sistema prepara el PDF con financiación y agenda el seguimiento posterior, pero la presentación inicial es humana.

---

### ✗ Respuestas a quejas, problemas post-operatorios o emergencias

Una autorespuesta a un paciente con dolor o complicación es **peligrosa y poco profesional**. Estos casos van con prioridad máxima al dentista responsable. Lo que sí automatizas: detectar palabras-tag de alerta ("dolor", "sangra", "se ha caído") y avisar al humano correcto en menos de un minuto.

---

### ✗ El consentimiento informado y la firma de aceptación

Por seguridad jurídica y por confianza con el paciente, el consentimiento se firma en consulta con el dentista presente, no en un PDF impersonal por email.

---

### ✗ La voz de marca en momentos críticos

El primer WhatsApp que recibe un lead, los emails al propietario, los mensajes de bienvenida. Una secuencia con tres faltas o el típico "[{nombre}] no encontrado" mata la confianza. Antes de soltar al sistema, una persona revisa palabra por palabra los 5-10 mensajes que verá un cliente nuevo.

---

### ✗ La voz de marca con pacientes nuevos

Los primeros 5-10 mensajes que recibe un paciente (acuse, cualificación, recordatorio primera visita, mensaje post-primera-visita) los revisa una persona palabra por palabra antes de soltar el sistema. Un fallo aquí en sector salud destruye confianza.

---



## ✗ Procesos que aún no entendéis manualmente

Si no puedes describir el proceso paso a paso (cómo cualifica recepción, qué hace cuando un paciente cancela, cómo se decide qué financiación ofrecer), no automatices. Primero ordena en papel.

Si lees este apartado y piensas "es de sentido común", correcto. Pero el 80% de los proyectos de automatización que fracasan en clínicas dentales fracasan exactamente aquí.



### ACCIÓN

## Qué hacer mañana

Asumiendo que has identificado tu fuga prioritaria, un plan de cinco días.



#### DÍA 1 · 1 HORA

### Mide

Saca el dato real, no la sensación. Si tu fuga es respuesta a leads, exporta los últimos 30 de Doctoralia y web y calcula la mediana. Si es no-show, mira la tasa real de los últimos 3 meses en tu software. Si es presupuestos, cuenta cuántos de los últimos 30 altos están sin cerrar. Si es reactivación, cuántos pacientes no han vuelto en 18 meses.

#### DÍA 2 · 2 HORAS

### Decide

Coge la fuga prioritaria y responde por escrito a las 2-3 preguntas de "decisión que toca" del capítulo correspondiente. No avances sin estas respuestas. Cualquier herramienta sin estas respuestas resueltas es dinero tirado.

#### DÍA 3 · 2-3 HORAS

### Diseña el flujo en papel

Literalmente, papel y boli. Qué dispara qué, en qué canal, con qué mensaje, con qué condiciones de salida. Si no cabe en una hoja, está sobreingenierizado.

#### DÍA 4 · MEDIO DÍA

### Lleva el flujo al sistema

Si es algo simple (cadencia de recordatorios), tu software dental lo hace. Si es complejo (WhatsApp Business API + IA + cruce contra Doctoralia + tu software), valora si lo montas internamente, lo subcontratas o usas plataformas como n8n o Make.

## Define cómo medirás que funciona

Métrica concreta, periodicidad, umbral de éxito. Sugerencias: para fuga 1, mediana de respuesta a leads de Doctoralia; para fuga 3, tasa de no-show mensual; para fuga 4, tasa de aceptación de presupuestos altos.

A los 30 días, revisa el dato. A los 90 días, decide si escalar a la siguiente fuga.

**Fuentes:** MIT Lead Response Management Study (Dr. James Oldroyd); Harvard Business Review — The Short Life of Online Sales Leads; Doctoralia — Estadísticas conversión clínicas con agenda online (+71%); Odontonet — Rentabilidad de recordatorios SMS en clínicas dentales españolas; Aimooova — Caso real chatbot clínica dental: -40% ausencias; ClinicBot — Tasas de no-show benchmarks España (8-22%); HelloMatik — Benchmarks de inasistencia en clínicas españolas; Vitaldent, Cleardent, Sanitas Dental — Precios implantes y ortodoncia 2025-2026; B-One Dental, Gaceta Dental — Tasa aceptación presupuestos objetivo 60%; Meta — WhatsApp Business open rates ~98%; INE — Servicios de odontología en España; Proclinic Group — Informe sector dental España.



### SIGUIENTE PASO

## ¿Tienes tu fuga prioritaria?

Un diagnóstico de 30 minutos. Sin compromiso. Sales con tres prioridades y, si encajamos, una propuesta a la semana.

Agendar diagnóstico de 30 minutos →

[moslabs.zohobookings.eu/#/moslabs](https://moslabs.zohobookings.eu/#/moslabs)



### Jose María Moscardó

Más de 8 años en marketing B2B (CHEP, Nielsen, OpenUp). Fundé MosLab para resolver exactamente este tipo de fugas en PYMEs españolas — con foco en clínicas dentales generalistas, implantología, ortodoncia y estética dental — usando automatización inteligente y consultoría de procesos.